Клинические рекомендации

Нейросенсорная тугоухость у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H90.3** — Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя **H90.4** — Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе **H90.5** — Нейросенсорная потеря слуха неуточненная **H91.1** — Пресбиакузис **H91.2** — Внезапная идиопатическая потеря слуха **H91.8** — Другие уточненные потери слуха
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 22.03.2023, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/518_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Главное 3

2. Клиника и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Причины 3

2.3 Степени тугоухости 3

2.4 Другие классификации 4

2.5 Клиническая картина 4

2.6 Жалобы и анамнез 4

3. Диагностика 5

3.1 Осмотр 5

3.2 Анализы 5

3.3 Акуметрия 5

3.4 Тональная пороговая аудиометрия 5

3.5 Тимпанометрия и акустическая рефлексометрия 6

3.6 Речевая аудиометрия и объективные методы 6

3.7 Как читать аудиограмму 6

3.8 Вестибулометрия и визуализация 7

3.9 Консультации и дифференциальная диагностика 7

4. Лечение и реабилитация 7

4.1 Внезапная и острая тугоухость 7

4.2 Хроническая тугоухость 8
4.3 Слухопротезирование 8
4.4 Кохлеарная имплантация 8
4.5 Показания к кохлеарной имплантации 9
4.6 Повторная имплантация 10
4.7 Физиотерапия и другие методы 10
4.8 Санаторно-курортное лечение 11
5. Наблюдение, профилактика, госпитализация 12
5.1 Госпитализация 12
6. Источник и актуальность 12
6.1 Неточности в самом тексте КР 12

1. Главное

- Диагноз ставят по жалобам, нормальной отоскопической картине и аудиологическим данным: тимпанограмма типа «А», средний порог воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц — 26 дБ и выше, костно-воздушный интервал — не больше 10 дБ.
- Степень тугоухости определяют по среднему порогу воздушного звукопроведения на тех же четырёх частотах: I — 26–40 дБ, II — 41–55 дБ, III — 56–70 дБ, IV — 71–90 дБ, глухота — 91 дБ и более.
- При внезапной и острой идиопатической потере слуха тональную аудиометрию проводят не позднее суток от первого обращения и повторяют перед выпиской, чтобы оценить эффект лечения.
- Пациента с острой сенсоневральной тугоухостью экстренно госпитализируют в ЛОР-отделение (или в неврологию) и назначают глюкокортикоиды по убывающей схеме.
- Слуховой аппарат подбирают при среднем пороге в зоне речевых частот на лучше слышащем ухе 31 дБ и выше; при двусторонней тугоухости IV степени или глухоте показана кохлеарная имплантация.
- При хронической тугоухости сурдолог-оториноларинголог наблюдает пациента и 1–2 раза в год повторяет тональную и речевую аудиометрию.

2. Клиника и классификация

2.1 Определение

Сенсоневральная (нейросенсорная) тугоухость (СНТ) — снижение слуха вплоть до его утраты, при котором поражается какой-либо участок звуковоспринимающего отдела слухового анализатора: от сенсорного аппарата улитки до невральных структур.

2.2 Причины

Основное условие развития тугоухости — повреждение чувствительных структур улитки. Начинается оно с дистрофии волосковых клеток, которая может быть обратимой, если помощь оказана вовремя.

К внезапной и острой СНТ приводят инфекции (грипп, эпидемический паротит, корь, клещевой энцефалит, менингококковый менингит, скарлатина, дифтерия, тифы, сифилис), острые интоксикации и ототоксические препараты (аминогликозиды, петлевые диуретики, противоопухолевые препараты, нестероидные противовоспалительные препараты и другие), болезни сердца и сосудов, включая нарушения мозгового кровообращения в вертебро-базилярном бассейне и нарушения реологии крови, дегенеративные болезни позвоночника с синдромом позвоночной артерии, а также моногенная наследственная патология и генетическая предрасположенность.

2.3 Степени тугоухости

Степень определяют по усреднённому порогу слышимости воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц.

Степень	Средний порог воздушного звукопроведения
I степень	26–40 дБ
II степень	41–55 дБ
III степень	56–70 дБ
IV степень	71–90 дБ
Глухота	91 дБ и более

2.4 Другие классификации

По остроте различают внезапную тугоухость, когда слух снижается в срок до 12 часов; острую, когда снижение развивается за 1–3 суток и сохраняется до месяца; подострую, когда снижение сохраняется 1–3 месяца; и хроническую (стойкую), когда оно держится дольше 3 месяцев.

По времени возникновения тугоухость бывает врождённой и приобретённой; по течению — стабильной, прогрессирующей, флюктуирующей и обратимой; по стороне поражения — односторонней и двусторонней, симметричной или асимметричной; по этиологии — генетической (наследственной), мультифакториальной (с наследственной предрасположенностью) и приобретённой.

2.5 Клиническая картина

Основные признаки сенсоневральной тугоухости у взрослых — снижение слуха, ухудшение разборчивости речи, шум в ушах и ощущение заложенности ушей.

На первом месте среди жалоб стоит снижение слуха вместе с шумом в ухе, чаще постоянным и преимущественно смешанной тональности.

Для острой сенсоневральной тугоухости характерно внезапное одно- или двустороннее снижение слуха вплоть до глухоты. Иногда — при острой травме, нарушении кровотока в лабиринтной артерии, токсическом поражении лабиринта — оно сопровождается шумом в ухе, а также острой вестибулярной и вегетативной дисфункцией: атаксией, головокружением, тошнотой, потливостью, тахикардией, колебаниями артериального давления и спонтанным нистагмом.

2.6 Жалобы и анамнез

Уточняют, когда возникло снижение слуха, как быстро нарастало, одинаково ли слышат правое и левое ухо, насколько выражены трудности общения. Активно расспрашивают о шуме в ушах, его выраженности и тональности, о вестибулярных нарушениях и неврологических симптомах.

В анамнезе особое внимание уделяют слуху ближайших родственников, характеру работы, перенесённым инфекционным и соматическим заболеваниям и наблюдению у других специалистов.

Выясняют факторы риска: тугоухость у родственников (особенно если совпадают степень, форма и условия возникновения), работу в условиях производственного шума, приём ототоксических препаратов, перенесённые инфекции (менингит, эпидемический паротит, корь, грипп и другие) и соматические болезни.

При острой тугоухости расспрашивают по плану: самочувствие и температура тела; какое ухо хуже слышит, когда и как снизился слух, менялся ли он, с чем пациент это связывает, снижался ли слух раньше; есть ли шум в ушах; было ли головокружение, какое оно (с определённым направлением или хаотичное), были ли тошнота, рвота, диарея, потливость и уменьшились ли головокружение и шум после рвоты; были ли раньше приступы системного головокружения и не ставили ли болезнь Меньера; не болеет ли пациент отитами, какие принимал лекарства, какое у него артериальное давление.

Также уточняют, нет ли гипертонической, ишемической или цереброваскулярной болезни; не было ли перед снижением слуха травмы головы или шейного отдела позвоночника, интенсивного звукового воздействия, плавания или приёма ванны; нет ли слабости в конечностях, асимметрии лица, нарушений чувствительности, движений и зрения; не лечился ли пациент недавно у стоматолога и не протезировал ли зубы.

3. Диагностика

Диагноз ставят на основании жалоб на снижение слуха, шум в ушах и ухудшение разборчивости речи, нормальной отоскопической картины и аудиологических данных. При тимпанометрии регистрируется тимпанограмма типа «А»; акустические рефлексы, в зависимости от степени потери слуха, регистрируются или нет. При тональной пороговой аудиометрии средний порог воздушного звукопроведения на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц составляет 26 дБ и более, а костно-воздушный интервал — 10 дБ и менее. Результаты речевой аудиометрии соответствуют тональной.

3.1 Осмотр

Убеждаются, что наружное и среднее ухо не изменены: при сенсоневральной тугоухости отоскопическая картина нормальная — слуховой проход свободный, барабанная перепонка перламутрово-серая, матовая, опознавательные знаки чётко видны.

Острая сенсоневральная тугоухость может развиться и у пациента с прошлой или текущей патологией среднего уха, поэтому отоскопия необходима, но для диагноза и выбора тактики её недостаточно.

Осматривают и другие ЛОР-органы, чтобы исключить болезни уха, носа и глотки, нарушающие воздушное звукопроведение.

3.2 Анализы

Всем пациентам делают общий (клинический) анализ крови, чтобы оценить общее состояние.

При соответствующей сопутствующей патологии исследуют липидный спектр (холестерин, ЛПНП, ЛПВП), общетерапевтическую биохимию (глюкоза, общий и прямой билирубин, АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина), коагулограмму (АЧТВ, МНО, протромбиновое время, фибриноген) и тиреотропный гормон.

3.3 Акуметрия

Всем пациентам с подозрением на СНТ составляют слуховой паспорт: исследуют слух шёпотной и разговорной речью и камертонами.

Акуметрия ориентировочна, но на ЛОР-приёме её достаточно, чтобы направить пациента к сурдологу-оториноларингологу.

3.4 Тональная пороговая аудиометрия

Всем пациентам с подозрением на СНТ определяют пороги слышимости методом тональной аудиометрии: по воздушному звукопроведению на частотах 125–8000 Гц и по костному — на 250–6000 Гц. Если пороги в норме, но пациент жалуется на снижение слуха или шум в ушах, исследуют расширенный диапазон частот — 125–20 000 Гц. Тональная аудиометрия — базовый метод и для первичной диагностики, и для динамического наблюдения.

При внезапной и острой идиопатической потере слуха аудиометрию проводят не позднее суток от первого обращения. Во время лечения, перед выпиской, её повторяют, чтобы зафиксировать восстановление порогов до нормы, их частичное восстановление или стабилизацию (отсутствие дальнейшего прогрессирования) и выбрать дальнейшую тактику.
При хронической двусторонней тугоухости по аудиограмме определяют показания к слухопротезированию — традиционному или имплантационному, включая кохлеарную имплантацию, — а при необходимости и к направлению на медико-социальную экспертизу и составлению индивидуальной программы реабилитации. Если пациент уже пользуется слуховым аппаратом, аппаратом костной проводимости или кохлеарным имплантом, оценивают эффективность слухопротезирования и при необходимости корректируют его.
При асимметричном снижении слуха лучше слышащее (не исследуемое) ухо маскируют.

Всем пациентам с подозрением на СНТ проводят надпороговые тесты — определение порогов дискомфорта, тест SISI, тест Люшера, — чтобы выявить нарушение функции громкости (рекрутмент).

Исследование можно дополнить сравнением порогов слышимости с порогами акустического рефлекса на частотах 500–4000 Гц.

3.5 Тимпанометрия и акустическая рефлексометрия

Всем пациентам с подозрением на СНТ проводят импедансометрию — тимпанометрию и регистрацию акустического рефлекса ипси- и контралатерально. Она нужна, чтобы исключить патологию среднего уха, отличить сенсоневральную тугоухость от кондуктивной и выявить поражение слухового и лицевого нервов, центральных слуховых путей и ядер VII и VIII пар черепных нервов на уровне продолговатого мозга и моста.

Если регистрировать рефлекс в широком временном окне, до 10 секунд, можно выявить его распад — признак ретрокохлеарного поражения.

Других типов тимпанограмм КР не описывают: для сенсоневральной тугоухости в критериях диагноза указана тимпанограмма типа «А», а акустические рефлексы в зависимости от степени потери слуха могут регистрироваться или отсутствовать.

3.6 Речевая аудиометрия и объективные методы

Всем пациентам с подозрением на СНТ проводят речевую аудиометрию в тишине и на фоне маскирующего шума.

Она даёт пороги восприятия и разборчивость речи; речетональная диссоциация — несоответствие речевой и тональной аудиограмм — может указывать на центральные нарушения.

Чтобы рано выявить признаки эндолимфатического гидропса, всем пациентам с подозрением на СНТ проводят электрокохлеографию.

Амбулаторно делают экстратимпанальную электрокохлеографию с внутриушным электродом, регистрируя ответы на стимулы со сгущением и разрежением в начальной фазе.

Для дифференциальной и топической диагностики всем пациентам с подозрением на СНТ исследуют коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП), вызванную отоакустическую эмиссию и отоакустическую эмиссию на частоте продукта искажения.

При асимметричной тугоухости целесообразно предъявлять стимулы низкой частоты и сравнивать межпиковые интервалы I–V с обеих сторон.

Отоакустическая эмиссия (ОАЭ) — слабые звуковые колебания, которые генерируют наружные волосковые клетки улитки; их регистрирует зонд в наружном слуховом проходе. ОАЭ не регистрируется, если пороги слышимости превышают 25–30 дБ на частотах 1–4 кГц, охватывающих большую часть речевого диапазона.

КСВП отражают электрическую активность слухового пути в ответ на звук и регистрируются с поверхности головы. Ответ выглядит как комплекс положительных пиков I–VII, самый стабильный из которых — V пик.

3.7 Как читать аудиограмму

Для периферического (кохлеарного) поражения типична нисходящая аудиограмма без костно-воздушного разрыва с признаками феномена ускоренного нарастания громкости (ФУНТ). При центральных — корковых и подкорковых — формах аудиограмма тоже чаще нисходящая и без костно-воздушного разрыва, но ФУНТ нет; при этом заметно страдают разборчивость речи в шуме и локализация звука.

3.8 Вестибулометрия и визуализация

Всем пациентам с подозрением на СНТ проводят вестибулометрию, чтобы оценить преддверие и полукружные каналы, выявить дисфункцию лабиринта и провести дифференциальную диагностику.

Чтобы оценить анатомические структуры, всем пациентам с подозрением на СНТ делают МРТ головного мозга, в том числе с внутривенным контрастированием (внутренние слуховые проходы, мостомозжечковые углы, задняя черепная ямка), и КТ височных костей высокого разрешения, в том числе с болюсным контрастированием. Особенно ценны эти методы при односторонней и асимметричной тугоухости, но важны при любой степени и симметрии снижения слуха.

Отдельной рекомендацией КР называет рентгенографию шейного отдела позвоночника с функциональными пробами и МРТ головного мозга, а при односторонней тугоухости — МРТ с контрастным усилением, чтобы подтвердить или исключить невриному слухового нерва.

МРТ уточняет дифференциальный и топический диагноз, уровень поражения слухового анализатора и анатомические особенности уха.

При соответствующих сопутствующих болезнях делают дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстра- и интракраниальных отделов) с цветным допплеровским картированием и триплексное сканирование вен.

3.9 Консультации и дифференциальная диагностика

При любом виде СНТ, независимо от длительности, пациента консультируют терапевт, невролог и эндокринолог. При аутоиммунных болезнях и иммунодефицитах исследуют иммунный статус.

Выявленные нарушения липидного и углеводного обмена позволяют построить патогенетическое лечение.

Дифференцируют с другими причинами снижения слуха: лабиринтопатиями после хронического гнойного отита, радикальной операции на ухе или перенесённого лабиринтита, поражением внутреннего уха при инфекциях и интоксикациях, невриномой VIII нерва, нарушением кровообращения в вертебро-базилярном бассейне, рассеянным склерозом, объёмными процессами мозга, черепно-мозговой и спинальной травмой, серной пробкой, сахарным диабетом, гипотиреозом, хронической почечной недостаточностью и другими.

До госпитализации диагноз острой сенсоневральной тугоухости предположительный. Но даже предположительный диагноз требует экстренной защиты сенсорных структур внутреннего уха и срочной эвакуации в многопрофильный стационар с ЛОР-отделением для дифференциальной диагностики и лечения.

Если по МРТ или КТ подозревают невриному слухового нерва или другое объёмное образование, пациента консультирует нейрохирург.

---

4. Лечение и реабилитация

4.1 Внезапная и острая тугоухость

С диагнозом «острая сенсоневральная тугоухость» пациента направляют на лечение в стационар или дневной стационар.

Пациента экстренно госпитализируют в отделение оториноларингологии или неврологии.

> КР в одном разделе допускает лечение острой тугоухости в дневном стационаре, а в следующей же рекомендации требует экстренной госпитализации в ЛОР-отделение или неврологию.

Назначают охранительный слуховой режим.

Проводят внутривенную инфузионную терапию глюкокортикоидами по убывающей схеме с учётом сопутствующих болезней, противопоказаний и возможных побочных эффектов.

Глюкокортикоиды можно вводить системно (внутрь или инфузионно) и местно (транстимпанально и транстубарно) и сочетать эти пути. В остром периоде сочетание позволяет снизить системную дозу без потери эффекта.

Если острая тугоухость предположительно ишемическая, на фоне сердечно-сосудистых нарушений, внутривенно вводят препараты для лечения заболеваний нервной системы, например #этилметилгидроксипиридина сукцинат.

Препарат	Доза
#Дексаметазон	Внутривенно на 100 мл натрия хлорида: в 1-й и 2-й дни — 24 мг, в 3-й и 4-й — 16 мг, в 5-й — 8 мг, в 6-й — 4 мг, в 7-й день препарат не вводят, в 8-й — 4 мг.
#Этилметилгидроксипиридина сукцинат	Раствор 5% — 4 мл на 16 мл натрия хлорида внутривенно, 8–10 дней.

4.2 Хроническая тугоухость

По индивидуальным показаниям, с учётом соматической патологии, проводят поддерживающие курсы лечения.

Назначают охранительный слуховой режим.

Лечат фоновые соматические болезни и 1–2 раза в год проводят курсы поддерживающей терапии таблетированными препаратами, улучшающими мозговой и лабиринтный кровоток и тканевой обмен.

При некоторых формах хронической тугоухости — наследственной, постменингитной, ототоксической — лечение в отдалённом периоде неэффективно.

Если при острой тугоухости слух ещё можно восстановить лечением, то при хронической возможность улучшить пороги лекарствами крайне мала. Корректнее говорить о лечении сопутствующих сердечно-сосудистых, неврологических, эндокринных и иммунных нарушений: оно одновременно служит профилактикой прогрессирования тугоухости. При вестибулярных нарушениях и ушном шуме проводят патогенетическое и симптоматическое лечение.

4.3 Слухопротезирование

Пациентам с хронической тугоухостью подбирают и настраивают слуховые аппараты, если средний порог на речевых частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) на лучше слышащем ухе составляет 31 дБ и более.

В алгоритме КР уточнено, что пороги должны быть стабильными, а при выборе учитывают возраст, профессию, образовательные потребности и социальную активность пациента.

Если слуховыми аппаратами пользоваться невозможно, устанавливают имплант среднего уха при условии, что пороги костного звукопроведения на 500 Гц не превышают 55 дБ, а на высоких частотах — 75 дБ.

У пациентов со сниженным зрением и другими инвалидизирующими болезнями показания к слухопротезированию шире, а требования к техническим средствам реабилитации выше.

4.4 Кохлеарная имплантация

При двусторонней тугоухости IV степени или глухоте проводят слухоречевую реабилитацию методом кохлеарной имплантации (КИ).

Сейчас это единственный эффективный метод реабилитации при тугоухости высокой степени и глухоте: комплекс аудиологических, сурдопедагогических, психологических и хирургических мер.

4.5 Показания к кохлеарной имплантации

№	Показание
1	Хроническая двусторонняя тугоухость IV степени с порогами слуха 80 дБ и более по КСВП
2	Хроническая двусторонняя тугоухость IV степени со средними порогами на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц 80 дБ и более по тональной пороговой аудиометрии
3	Пороги в свободном звуковом поле с оптимально подобранными слуховыми аппаратами (бинаурально) выше 55 дБ на частотах 2–4 кГц
4	Нет выраженного улучшения восприятия речи с оптимально подобранными аппаратами при среднем пороге выше 95 дБ после 3–6 месяцев пользования, по заключению сурдопедагогической комиссии
5	Разборчивость речи в свободном звуковом поле с оптимально подобранными аппаратами меньше 40% после 3–6 месяцев пользования, по заключению сурдопедагогической комиссии

> Пороги для кохлеарной имплантации в КР не согласованы с её же классификацией. IV степень по разделу 1.5 — это 71–90 дБ, а показания 1 и 2 говорят об «IV степени с порогами 80 дБ и более», то есть охватывают и глухоту, но не всю IV степень. Показание 4 требует среднего порога выше 95 дБ — это уже глухота, хотя названо «высокой степенью тугоухости».

Абсолютные противопоказания — полная аплазия внутреннего уха (аномалия Мишеля), полная облитерация улитки, тяжёлые соматические, неврологические и психические болезни, недостаточность интеллекта и отсутствие коммуникативных возможностей (исключения возможны для слабовидящих и слепых).

Относительные противопоказания — отсутствие мотивации и возможностей для длительной реабилитации, частичная облитерация улитки, выраженные аномалии улитки и слухового нерва, обострение острых или хронических воспалительных болезней ЛОР-органов и ретрокохлеарная патология. В трёх случаях — при облитерации, аномалиях и ретрокохлеарной патологии — решает врачебная комиссия центра, где оперируют.

Двустороннюю (бинауральную) имплантацию делают одномоментно или последовательно. Она даёт стимуляцию слуховых путей с обеих сторон, локализацию звука, лучшую разборчивость речи в шуме и в разговоре нескольких людей, более естественное и менее утомительное восприятие и сохраняет слух при поломке одного импланта.

Одномоментная бинауральная имплантация показана при хронической двусторонней тугоухости IV степени и глухоте после менингита (с выпиской из стационара) по решению врачебной комиссии.
Последовательная — при оссификации или облитерации улитки после перелома височных костей и при отосклерозе, при аномалиях развития внутреннего уха, а также при хорошей динамике слуха и речи после односторонней имплантации и высокой мотивации; всё — по решению врачебной комиссии центра. Объём последовательных имплантаций не должен превышать 10% годового объёма этой помощи в учреждении.
Противопоказания те же, что к имплантации вообще, а также интервал между операциями, когда система КИ используется с одной стороны больше 5 лет.

Объём кохлеарной имплантации взрослым в учреждении не должен превышать 20% государственного задания по этому виду высокотехнологичной помощи. Гарантийный срок на имплант — не меньше 10 лет, на речевой процессор — не меньше 5 лет.

4.6 Повторная имплантация

Причина	Что делают
Техническая неисправность импланта	Реимплантация
Гнойное воспаление среднего уха на стороне импланта (хронический гнойный средний отит, мастоидит)	Санация полостей среднего уха, тимпанопластика. Если имплант сохранить нельзя — эксплантация с сохранением электродной решётки в улитке и одномоментная имплантация на другом ухе при отсутствии противопоказаний
Экструзия корпуса импланта	Эксплантация с сохранением электродной решётки в улитке и одномоментная имплантация на другом ухе при отсутствии противопоказаний
Миграция корпуса импланта, при которой нельзя пользоваться речевым процессором, или экстракохлеарное положение электродной решётки	В таблице КР не заполнено

Реимплантацию выполняют системой того же производителя; систему другой фирмы можно поставить только за внебюджетные средства, что указывают в информированном согласии.

Если имплант вышел из строя в гарантийный срок, производитель по заявлению медицинской организации в течение 10 суток даёт первичное заключение и в течение 30 суток после него предоставляет новый имплант. Окончательно неисправность устанавливают технической экспертизой извлечённого импланта, которая длится не больше трёх месяцев.

4.7 Физиотерапия и другие методы

Пациентам с тугоухостью и шумом в ушах проводят электростимуляцию.

Используют постоянный импульсный ток прямоугольной формы и флюктуирующие токи силой 0,5–2 мА; частоту подбирают по частоте шума. Процедура 10–15 минут, курс 10–15 процедур. Противопоказана пользователям кохлеарного, стволомозгового импланта и импланта среднего уха.

Проводят курс гипербарической оксигенации: 10–20 процедур при давлении 1,5–2,5 атм по 1–2 часа.

Начинать лучше в первый месяц от начала болезни; результат лучше в сочетании с глюкокортикоидами.

В курс лечения включают рефлексотерапию.

Она эффективна как дополнительное лечение, в том числе на поздней стадии; электропунктура эффективнее классической иглорефлексотерапии. Импульсы 1 мс переменной полярности частотой 61 Гц, амплитуда — до лёгкого покалывания, по 10 минут на пару точек; курс 10–15 процедур ежедневно или через день.

Проводят электронейростимуляцию головного мозга.

Лучше всего она помогает при начальной и лёгкой степени тугоухости, в том числе в виде аудиоселективной транскраниальной электростимуляции: ток до 1,0 мА, по 20 минут, 15 процедур через день. Противопоказана пользователям имплантов.

В курс лечения включают дозированные физические нагрузки.

Это баланстерапия и дыхательная гимнастика курсами 3 месяца, 3 раза в неделю по 40 минут, а также ежедневный терренкур не меньше 20 минут.

Проводят транскраниальную магнитную стимуляцию, в том числе при шуме в ушах на фоне тугоухости.

Ритмически стимулируют височно-теменные, лобные и префронтальные области коры. Противопоказана пользователям имплантов.

Применяют лекарственный ультрафонофорез и внутриушной электрофорез лекарственных препаратов.

В слуховой проход вливают 1,5–2,0 мл лекарства, нагретого до 36–37 °C. Процедура 5–15 минут при частоте 880 кГц, мощности до 0,2 Вт/см² и гальваническом токе до 0,3 мА; курс 10–12 процедур. Противопоказана пользователям имплантов.

В курс лечения включают медицинский массаж.

Делают лечебный массаж шеи и воротниковой зоны — классический, точечный или вакуумный — ежедневно, курсом до 10 процедур.

В комплексной терапии применяют лазеротерапию.

Внутривенное лазерное облучение крови сочетают с введением трентала: длина волны 630 нм, мощность 1,0–2,0 мВт, 25–30 минут, 5–7 процедур ежедневно. При эндауральной методике длина волны 808–810 нм, плотность потока 8–15 мВт/см², 8–10 минут, 12–14 процедур ежедневно.

В курс лечения включают слуховой тренинг в виртуальной реальности.

Он показан как дополнительный метод при хронической тугоухости лёгкой степени и скрытой потере слуха: ежедневно 7 дней по 15 минут с одной паузой в 2 минуты.

Проводят вестибулярные тренировки, в том числе в виртуальной реальности.

Тренируют равновесие ежедневно или через день по 30 минут, курс 20 процедур.

Для улучшения слуха, в том числе после кохлеарной имплантации, используют мобильные приложения с шумоподавлением в реальном времени.

Методы из пунктов 4–15 раздела реабилитации обычно применяют во время санаторно-курортного лечения, после консультации врача.

4.8 Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение проводят в хронической стадии тугоухости, врождённой или приобретённой; в таблице КР перечислены все степени — от I до глухоты.

Код	Заболевание
H90.3	Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя
H90.4	Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе
H90.5	Нейросенсорная потеря слуха неуточнённая

Подходят бальнеологические курорты с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми и йодобромными водами, а также климатические — приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные — и грязевые.

Если ни слуховые аппараты, ни кохлеарные импланты не помогают, нужен другой способ общения: обучение дактилю и жестовому языку, сурдоперевод.

5. Наблюдение, профилактика, госпитализация

Пациентов с хронической тугоухостью диспансерно наблюдает сурдолог-оториноларинголог в сурдологическом кабинете или центре по месту жительства, оценивая эффективность лечения и состояние пациента.

Эффективность слуховых аппаратов оценивают речевой аудиометрией в свободном звуковом поле в тишине и в шуме и анкетированием о качестве жизни. Тональную аудиометрию, речевую аудиометрию в тишине и в шуме и коррекцию настроек слухового аппарата по их результатам проводят 1–2 раза в год.
При остром ухудшении или быстром прогрессировании тугоухости исследование повторяют незамедлительно, чтобы успеть провести лечение и восстановить пороги.
После кохлеарной имплантации речевую аудиометрию в свободном поле в тишине и в шуме проводят после подключения процессора и на каждой настроечной сессии, 2–4 раза в год, плюс анкетирование. Тональную и речевую аудиометрию повторяют 1–2 раза в год, речевой процессор настраивают 2–4 раза в год.

Для оценки слуховых аппаратов КР приводит опросник «Международная оценка использования слуховых аппаратов» из 7 вопросов. Если во всех вопросах выбраны ответы 1 и 2, нужно скорректировать настройки, повторно обследовать слух и направить пациента на слухоречевую реабилитацию; если везде вариант 3 — нужно вмешаться в настройки; при вариантах 4 и 5 настройки менять не нужно.

При односторонней тугоухости нужна дополнительная дифференциальная диагностика, а при вестибулярных нарушениях и ушном шуме — дополнительные диагностические, лечебные и реабилитационные меры.

По показаниям пациента направляют на медико-социальную экспертизу для решения вопроса о стойкой нетрудоспособности. Вместе с группой инвалидности составляют индивидуальную программу реабилитации с выбранным способом коррекции слуха: традиционным или имплантационным слухопротезированием либо кохлеарной имплантацией.

5.1 Госпитализация

Показания к госпитализации — острая сенсоневральная тугоухость и замена речевого процессора системы кохлеарной имплантации (в круглосуточном или дневном стационаре).

Выписывают при выздоровлении или улучшении.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Нейросенсорная тугоухость у взрослых»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 22.03.2023 (год утверждения в PDF не заполнен: «20__»)
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По правилу из приложения А2 КР — не реже одного раза в три года; следующая версия ожидалась не позднее марта 2026 года, но на 22.10.2026 в рубрикаторе действует эта
Код в рубрикаторе	518_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности в самом тексте КР

- Пороги для кохлеарной имплантации не согласованы с классификацией: IV степень — 71–90 дБ, а показания говорят об «IV степени с порогами 80 дБ и более» и о среднем пороге «более 95 дБ» (по классификации это глухота).

- В разделе 3.1 пациента с острой тугоухостью направляют «в стационар или дневной стационар», а в следующей рекомендации — на экстренную госпитализацию.
- В рекомендации о слуховых аппаратах речевые частоты указаны как «500, 1000, 2000 и 4000 кГц» — должно быть «Гц».
- В таблице реимплантации у строки «Миграция корпуса внутренней части кохлеарного импланта…» не заполнена графа «Методы лечения».
- Одна и та же рекомендация об охранительном слуховом режиме имеет при острой тугоухости УДД 5, а при хронической — УДД 4.
- МРТ головного мозга рекомендована дважды, отдельными рекомендациями с разным объёмом (во второй — вместе с рентгенографией шейного отдела позвоночника).
- В схеме #дексаметазона на 7-й день препарат не вводят, а на 8-й снова дают 4 мг; так в тексте КР.
- Год утверждения на титульном листе не заполнен («20__»); PDF — скан с распознанным текстом, в нём много ошибок распознавания (например, «8181» вместо SISI, «1рз1 и соШга» вместо ipsi и contra).